JEDEN PRZYPADEK TYGODNIOWO™ · TAJNY BONUS

12-Miesięczna Mapa Rozwoju Klinicznego

Warstwa ponad 52-tygodniowym programem: jakie umiejętności zostaną zdobyte w każdym miesiącu, na jakie typy przypadków należy zwracać szczególną uwagę i jak ocenić siebie pod koniec miesiąca.

Kompendium Ortodonty

Spis treści

Jak używać mapy drogowej

Tabela samooceny

1. kwartał · Miesiąc 1–3

2. kwartał · Miesiąc 4–6

3. kwartał · Miesiąc 7–9

4. kwartał · Miesiąc 10–12

Oceny kwartalne

Następny krok

NA POCZĄTEK

Jak używać mapy drogowej

Raz w miesiącu, 10 minut.

1. **Na początku miesiąca** przeczytać kartę tego miesiąca: tygodnie, umiejętności, typy przypadków.
2. **Przez cały miesiąc** zwracać szczególną uwagę na typy przypadków wymienione na karcie wśród własnych pacjentów; w każdym z nich zadawać sobie pytania tygodnia.
3. **Pod koniec miesiąca** zaznaczyć własne pola oceny i napisać, czy ukończono kamień milowy.
4. **W każdym kwartale** wypełnić ponownie tabelę oceny i porównać z poprzednim wynikiem.

Co mierzy ta mapa, a czego nie

Ta mapa mierzy porządek i ciągłość rozumowania klinicznego. Nie gwarantuje sukcesu klinicznego ani wyników leczenia; każda decyzja podejmowana jest na podstawie badania i dokumentacji specyficznej dla pacjenta.

KWARTAŁ	MIESIĄCE	TYGODNIE	SKUPIENIE
1	1–3	1–13	Podstawy, diagnoza, czytanie rentgenogramów
2	4–6	14–26	Planowanie, zarządzanie miejscem, zakotwienie, różnicowanie klasy II
3	7–9	27–39	Leczenie strzałkowe, problemy pionowe i poprzeczne
4	10–12	40–52	Mechanika, kończenie, stabilność, omówione przypadki

OCENA

Tabela samooceny

1 = jeszcze nie jestem pewien · 5 = mogę swobodnie uzasadnić i opowiedzieć.

OBSZAR	POCZĄTEK	MIESIĄC 3	MIESIĄC 6	MIESIĄC 9	MIESIĄC 12
Porządek badania i dokumentacji					
Czytanie pantomogramu					
Interpretacja cefalometryczna					
Lista problemów i cele					
Decyzje o ekstrakcji / miejscu					
Plan zakotwienia					
Decyzje dotyczące klasy II					
Decyzje dotyczące klasy III					
Problemy pionowe					
Problemy poprzeczne					
Kontrola mechaniczna (tork, zamykanie luk)					
Kończenie i retencja					
Prezentacja przypadku					

> *Celem nie jest wysoki wynik, lecz uczciwy początek i widoczna zmiana. Uczynić dwa najsłabsze obszary priorytetem kolejnego kwartału.*

1. KWARTAŁ

Miesiąc 1–3

Miesiąc 1 · Ugruntowanie podstaw

TYDZIEŃ 1–5

UMIEJĘTNOŚCI

- Zapisywanie klasy Angle u każdego nowego pacjenta osobno po obu stronach
- Używanie 6 kluczy okluzji w kontroli końcowej
- Wyjaśnianie niekontrolowanego wychylenia (tipping) za pomocą centrum oporu

PRZYPADKI, NA KTÓRE NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ

- Pacjenci kontrolni w uzębieniu mieszanym
- Przypadki prostego stłoczenia
- Przypadki w fazie końcowej

SAMOOCENA NA KONIEC MIESIĄCA

- [ ] Potrafię wymienić sześć kluczy z pamięci i w kolejności.
- [ ] Potrafię wyjaśnić logikę mojej kolejności łuków koledze.
- [ ] Zapisuję czynniki ryzyka resorpcji korzeni w dokumentacji początkowej.

Kamień milowy: Wykonanie kontroli w przypadku końcowym, zaznaczając sześć kluczy jeden po drugim.

Miesiąc 2 · Ustalenie kolejności badania

TYDZIEŃ 6–9

UMIEJĘTNOŚCI

- Zapisywanie wywiadu, profilu i symetrii w tej samej kolejności
- Dostrzeganie wskazówek pionowych w uśmiechu i badaniu wewnątrzustnym
- Kontrola różnicy CR-CO u każdego pacjenta
- Wykonywanie analizy miejsca wraz z krzywą Spee

PRZYPADKI, NA KTÓRE NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ

- Pacjenci na pierwszej wizycie
- Dzieci z przesunięciem czynnościowym
- Stłoczenie średniego stopnia

SAMOOCENA NA KONIEC MIESIĄCA

- [ ] Moje notatki z pierwszej wizyty mają te same nagłówki u każdego pacjenta.
- [ ] Potrafię odróżnić przesunięcie czynnościowe od prawdziwej asymetrii.
- [ ] Wykonałem analizę Boltona w co najmniej jednym przypadku.

Kamień milowy: Zapisanie pięciu kolejnych pierwszych wizyt przy użyciu tego samego formularza, bez braków.

Miesiąc 3 · Czytanie rentgenogramów i lista problemów

TYDZIEŃ 10–13

UMIEJĘTNOŚCI

- Czytanie pantomogramu w kolejności Narzędzia 1
- Interpretacja cefalometrii w trzech zdaniach
- Zapisywanie listy problemów w czterech nagłówkach
- Rozpoznawanie wskazań do wczesnego leczenia

PRZYPADKI, NA KTÓRE NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ

- Podejrzenie kła zatrzymanego
- Przypadki początkowe klasy II i klasy III
- Kandydaci do wczesnego leczenia

SAMOOCENA NA KONIEC MIESIĄCA

- [ ] Ukończyłem pierwsze 5 ćwiczeń z Zeszytu Ćwiczeń z Pomiarów Cefalometrycznych.
- [ ] Przy każdym nowym przypadku piszę listę problemów.
- [ ] Dodałem palpację kłów do rutynowego badania.

Kamień milowy: Rozwiązanie Bloków 1 i 2 ze 100 Omówionych Pytań Klinicznych i zapisanie wyniku.

2. KWARTAŁ

Miesiąc 4–6

Miesiąc 4 · Decyzje planistyczne

TYDZIEŃ 14–18

UMIEJĘTNOŚCI

- Uzasadnianie granic kamuflażu
- Zapisywanie kolejności mechaniki w planie
- Wczesne dostrzeganie problemów ze współpracą
- Ustalanie kolejności zespołu u pacjenta dorosłego i z ryzykiem periodontologicznym
- Zapisywanie decyzji o ekstrakcji wraz z uzasadnieniem

PRZYPADKI, NA KTÓRE NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ

- Przypadki szkieletowe na granicy
- Przypadki dorosłych i multidyscyplinarne
- Przypadki z decyzją ekstrakcja/brak ekstrakcji

SAMOOCENA NA KONIEC MIESIĄCA

- [ ] W każdym planie cele są zapisane przed mechaniką.
- [ ] W jednym przypadku użyłem Narzędzia 2 od początku do końca.
- [ ] W jednym przypadku multidyscyplinarnym napisałem notatkę konsultacyjną za pomocą szablonu.

Kamień milowy: Zaprezentowanie przypadku koledze za pomocą szablonu prezentacji 5-minutowej.

Miesiąc 5 · Zarządzanie miejscem

TYDZIEŃ 19–22

UMIEJĘTNOŚCI

- Planowanie IPR poprzez pomiar
- Rozróżnianie ekspansji zębowej od szkieletowej
- Podejmowanie decyzji o utrzymywaczu miejsca
- Klasyfikowanie potrzeby zakotwienia na początku przypadku

PRZYPADKI, NA KTÓRE NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ

- Lekkie do umiarkowanego stłoczenie
- Wąskość poprzeczna
- Wczesna utrata zęba mlecznego
- Przypadki z ekstrakcją

SAMOOCENA NA KONIEC MIESIĄCA

- [ ] Mierzę i zapisuję ilość IPR za każdym razem.
- [ ] W decyzji o ekspansji zapisuję granice periodontologiczne.
- [ ] W każdym przypadku z ekstrakcją zapisałem klasę zakotwienia w planie.

Kamień milowy: Co najmniej 8/10 poprawnych odpowiedzi w Bloku 4.

Miesiąc 6 · Zakotwienie i różnicowanie klasy II

TYDZIEŃ 23–26

UMIEJĘTNOŚCI

- Wymienianie wskazań do miniimplantów i punktów kontrolnych
- Rozróżnianie, czy klasa II jest zębowa czy szkieletowa
- Ocena ryzyka urazu przy zwiększonym nagryzie poziomym
- Ustalanie kolejności leczenia w klasie II/2

PRZYPADKI, NA KTÓRE NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ

- Przypadki maksymalnego zakotwienia
- Klasa II/1 i II/2
- Dzieci z historią urazu

SAMOOCENA NA KONIEC MIESIĄCA

- [ ] Użyłem Narzędzia 3 w jednym przypadku.
- [ ] Szukam objawów utraty zakotwienia podczas kontroli.
- [ ] Ukończyłem Blok 5.

Kamień milowy: Pierwsza połowa roku: co najmniej 22/26 tygodni zaznaczonych na karcie śledzenia i drugie wypełnienie tabeli samooceny.

3. KWARTAŁ

Miesiąc 7–9

Miesiąc 7 · Leczenie klasy II i klasy III

TYDZIEŃ 27–31

UMIEJĘTNOŚCI

- Wybieranie odpowiedniego pacjenta i czasu na aparat czynnościowy
- Monitorowanie efektów ubocznych wyciągów klasy II
- Różnicowanie pseudo klasy III
- Wyjaśnianie rodzinie granic protrakcji i chirurgii

PRZYPADKI, NA KTÓRE NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ

- Klasa II w okresie wzrostu
- Wczesna klasa III
- Dorośli na granicy chirurgii

SAMOOCENA NA KONIEC MIESIĄCA

- [ ] Wyraźnie wyjaśniam rodzinie możliwość wzrostu i nawrotu.
- [ ] Ograniczam wyciągi klasy II u pacjenta hiperdywergentnego.
- [ ] Ukończyłem Bloki 6 i 7.

Kamień milowy: Skonsultowanie przypadku klasy III z kolegą za pomocą szablonu 60-sekundowego.

Miesiąc 8 · Problemy pionowe

TYDZIEŃ 32–35

UMIEJĘTNOŚCI

- Różnicowanie typu zgryzu otwartego
- Kierowanie multidyscyplinarne w przypadku nawyków
- Decyzja o intruzji/ekstruzji w zgryzie głębokim
- Wybieranie mechaniki zgodnie z wzorcem pionowym

PRZYPADKI, NA KTÓRE NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ

- Zgryz otwarty związany z nawykiem
- Zgryz głęboki
- Pacjenci hiper- i hipodywergentni

SAMOOCENA NA KONIEC MIESIĄCA

- [ ] W każdym przypadku mierzę widoczność siekaczy w spoczynku.
- [ ] Wzorzec pionowy zapisuję w pierwszej linii planu.
- [ ] Ukończyłem 10 ćwiczeń z zeszytu cefalometrii.

Kamień milowy: Uzasadnienie decyzji w przypadku zgryzu głębokiego za pomocą dwóch kryteriów.

Miesiąc 9 · Problemy poprzeczne i zamykanie luk

TYDZIEŃ 36–39

UMIEJĘTNOŚCI

- Różnicowanie zgryzu krzyżowego zębowego i szkieletowego
- Przestrzeganie granic periodontologicznych ekspansji u dorosłych
- Dostrzeganie utraty torku i nagryzu pionowego przy zamykaniu luk

PRZYPADKI, NA KTÓRE NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ

- Zgryz krzyżowy pojedynczego zęba i obustronny
- Dorośli z cienkim fenotypem
- Przypadki w fazie zamykania luk

SAMOOCENA NA KONIEC MIESIĄCA

- [ ] Monitoruję efekt ekstruzji wyciągów krzyżowych.
- [ ] Nie zaczynam zamykania luk bez prostokątnego łuku roboczego.
- [ ] Ukończyłem Blok 8.

Kamień milowy: Wykonanie kontroli torku i nagryzu pionowego wszystkich przypadków w fazie zamykania luk za pomocą listy kontrolnej.

4. KWARTAŁ

Miesiąc 10–12

Miesiąc 10 · Mechanika pomocnicza i kończenie

TYDZIEŃ 40–44

UMIEJĘTNOŚCI

- Planowanie zapobiegania nawrotowi rotacji
- Bezpieczne planowanie trakcji zębów zatrzymanych
- Monitorowanie efektów ubocznych aparatów pomocniczych
- Stosowanie listy kontrolnej kończenia przed zdjęciem zamków

PRZYPADKI, NA KTÓRE NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ

- Kły zatrzymane
- Pionizacja trzonowców i przygotowanie protetyczne
- Przypadki kończące się

SAMOOCENA NA KONIEC MIESIĄCA

- [ ] Nie zostawiam repozycji zamków na koniec.
- [ ] Zapisuję kierunek siły w trakcji.
- [ ] Ukończyłem Blok 9.

Kamień milowy: Pełne zastosowanie listy kontrolnej kończenia w trzech przypadkach.

Miesiąc 11 · Stabilność i retencja

TYDZIEŃ 45–48

UMIEJĘTNOŚCI

- Różnicowanie przyczyny przesunięcia linii środkowej
- Wykonywanie settlingu
- Wybieranie i wyjaśnianie odpowiedniej retencji pacjentowi
- Analiza przypadku z nawrotem bez obwiniania

PRZYPADKI, NA KTÓRE NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ

- Pacjenci po zakończonym leczeniu
- Kontrole retencji
- Przypadki z nawrotem

SAMOOCENA NA KONIEC MIESIĄCA

- [ ] Plan retencji zapisuję na początku leczenia.
- [ ] Kontrole retencji wpisałem do kalendarza.
- [ ] Ukończyłem Blok 10.

Kamień milowy: Ustanowienie regularnej listy kontrolnej dla pacjentów w okresie retencji.

Miesiąc 12 · Omówione przypadki i ocena roku

TYDZIEŃ 49–52

UMIEJĘTNOŚCI

- Planowanie przypadku od listy problemów do retencji od początku do końca
- Analiza przedłużającego się leczenia za pomocą Narzędzia 5
- Używanie szablonów prezentacji przypadków w prawdziwym przypadku

PRZYPADKI, NA KTÓRE NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ

- Przypadki, które utknęły lub przedłużyły się w tym roku
- Przypadki z pełną dokumentacją początkową i końcową

SAMOOCENA NA KONIEC MIESIĄCA

- [ ] Na karcie śledzenia zaznaczone co najmniej 46 z 52 tygodni.
- [ ] Ukończyłem tygodnie zaznaczone jako powtórki.
- [ ] Wypełniłem własną tabelę oceny po raz trzeci.

Kamień milowy: Przygotowanie zakończonego przypadku w formie 5-minutowej prezentacji lub plakatu zgodnie z zasadami przed/po.

RAZ NA TRZY MIESIĄCE

Oceny kwartalne

Na koniec 3, 6, 9 i 12 miesiąca należy odpowiedzieć pisemnie na te pytania.

Koniec 1. kwartału

Liczba tygodni zaznaczonych w karcie postępów

Dwa obszary największego rozwoju

Dwa najsłabsze obszary

Jedna lekcja kliniczna, którą przyswoiłem w tym kwartale

Priorytet na kolejny kwartał

Koniec 2. kwartału

Liczba tygodni zaznaczonych w karcie postępów

Dwa obszary największego rozwoju

Dwa najsłabsze obszary

Jedna lekcja kliniczna, którą przyswoiłem w tym kwartale

Priorytet na kolejny kwartał

Koniec 3. kwartału

Liczba tygodni zaznaczonych w karcie postępów

Dwa obszary największego rozwoju

Dwa najsłabsze obszary

Jedna lekcja kliniczna, którą przyswoiłem w tym kwartale

Priorytet na kolejny kwartał

Koniec 4. kwartału

Liczba tygodni zaznaczonych w karcie postępów

Dwa obszary największego rozwoju

Dwa najsłabsze obszary

Jedna lekcja kliniczna, którą przyswoiłem w tym kwartale

Priorytet na kolejny kwartał

Materiał ma charakter edukacyjny. Nie zastępuje badania klinicznego, decyzji lekarza ani opinii specjalisty.

Następny krok

Czy otwarto kartę na ten miesiąc? Należy wydrukować Tygodniową Kartę Postępów i rozpocząć od pierwszego tygodnia **52-Tygodniowego Programu Ćwiczeń na Przypadkach**.

Na koniec każdego kwartału należy ponownie rozwiązać odpowiednie bloki **100 Omówionych Pytań Klinicznych**. Pod koniec roku należy zaprezentować zakończony przypadek przy użyciu **Szablonów Prezentacji Przypadków dla Kolegów** i powrócić do **Modułu 09** Kompendium Ortodonty.